PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Fiche de révision écrite · Semestre 1 · Cours et notes de séance

PRIORITÉ EXPRESSÉMENT ANNONCÉE POUR LES PARTIELS

Les **définitions doivent être rédigées intégralement**, sous forme de phrases complètes (sujet, verbe et complément). Une suite de mots-clés ou une formulation tronquée ne suffit pas. Dans un témoignage clinique, il faut savoir identifier les notions pertinentes, les définir et justifier précisément leur application.

COMMENT UTILISER CETTE FICHE

Premier passage : lire le déroulé conceptuel. Deuxième passage : appliquer les notions aux situations de patients. Avant l'évaluation : relire la section « Pièges QCM », la synthèse puis mémoriser les définitions complètes du lexique final.

Plan de révision

Plan de révision 2

01 · Fondamentaux : santé, maladie et qualité de vie 2

02 · Vivre la maladie : plainte, douleur et représentations 4

03 · Modèle intégratif et déterminants de la santé 5

04 · Soutien social : reçu, perçu et mobilisé 5

05 · Vulnérabilité, personnalité et résilience 6

06 · Stress, évaluation cognitive et contrôle perçu 7

07 · Stratégies d'ajustement : coping 8

08 · Angoisse et mécanismes de défense face à la maladie 8

09 · Annonce du diagnostic et réactions psychiques 9

10 · Le corps en psychologie : schéma, image et identité 10

11 · Méthode de mobilisation des concepts à l'examen 11

12 · À retenir : connexions importantes 12

13 · Pièges QCM et confusions à éviter 13

14 · Synthèse générale — L'essentiel du cours 13

15 · Définitions et mots-clés 14

Repère méthodologique : ne pas confondre un **concept théorique**, une **expérience subjective du patient** et une **interprétation du soignant**. Les trois peuvent éclairer la situation sans se substituer les uns aux autres.

01 · Fondamentaux : santé, maladie et qualité de vie

Une psychologie de la personne, et non seulement du diagnostic

La psychologie de la santé étudie les déterminants biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux de la santé, de la maladie et des comportements de santé. Elle s'intéresse au sens donné par la personne à son état et à la manière dont elle traverse le soin, la prévention, l'annonce, la douleur ou le handicap.

À RETENIR

Dans un témoignage, ne pas déduire le vécu psychique du seul diagnostic. Demander ce que la maladie **signifie** pour la personne, ce qu'elle lui fait perdre et quelles ressources elle mobilise.

Santé : modèle global et dynamique

La définition de l'OMS citée dans le cours envisage la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, au-delà de l'absence de maladie. Le cours interroge les limites d'un « complet bien-être » difficile à atteindre et insiste sur une vision évolutive : équilibre, capacités de satisfaire les besoins, ressources individuelles et sociales et adaptation au milieu.

Conception	Ce qu'elle permet de comprendre
Biomédicale	État biologique, atteintes, symptômes, diagnostic et traitement.
Globale / biopsychosociale	Interactions entre le corps, le vécu psychologique, les relations, la culture et les conditions de vie.
Dynamique et subjective	La santé change dans le temps et dépend aussi de la manière dont la personne évalue ses propres possibilités.

Le modèle des besoins de Maslow est mobilisé à titre de repère : besoins physiologiques, sécurité, appartenance/affection, estime et accomplissement. La maladie peut modifier simultanément plusieurs besoins.

Santé perçue et qualité de vie

La **santé perçue** correspond à l'auto-évaluation de sa santé physique et psychique. La qualité de vie intègre aussi l'autonomie, les relations, la place sociale et les conditions environnementales. Une personne atteinte d'une maladie chronique peut déclarer une qualité de vie satisfaisante ; à l'inverse, l'absence d'atteinte somatique identifiée ne garantit pas un bien-être vécu.

Domaines de qualité de vie	Repères
Physique	Douleur, mobilité, fatigue, sommeil, effets du traitement, énergie.
Psychologique	Émotions, humeur, estime de soi, mémoire, concentration, vécu de l'avenir.
Social	Liens, soutien, vie familiale, activités, travail, place dans les groupes.
Environnement et autonomie	Logement, sécurité, ressources financières, accès aux soins, liberté d'action.

EN PRATIQUE

Distinguer l'évaluation extérieure de la santé (**hétéro-évaluation**) de la perception du patient (**auto-évaluation**). Éviter de corriger le vécu du patient avec de seuls résultats médicaux.

02 · Vivre la maladie : plainte, douleur et représentations

Trois dimensions complémentaires de la maladie

Terme	Dimension	Question dans un témoignage
Disease	Maladie comme objet biomédical.	Quels signes, lésions, mécanismes et diagnostics ?
Illness	Expérience subjective de la maladie.	Que ressent et raconte la personne ?
Sickness	Dimension sociale de la maladie.	Comment est-elle reconnue, accueillie, stigmatisée dans son milieu ?

La maladie chronique peut modifier durablement le rapport à soi, l'autonomie, le projet de vie et l'organisation familiale. Le handicap s'envisage aussi sous l'angle des restrictions de fonctionnement et de participation, en plus des atteintes corporelles.

Douleur, souffrance et plainte ne sont pas synonymes

La douleur est abordée comme une expérience sensorielle et émotionnelle personnelle. La perception de la douleur ne se déduit pas mécaniquement d'une lésion : une douleur peut exister sans lésion objectivable, et une lésion peut ne pas entraîner de plainte douloureuse. La souffrance psychique peut aller jusqu'à la sidération ou à des difficultés pour exprimer son état.

La **plainte** est la manière dont une personne adresse ou manifeste quelque chose de son vécu à un autre. Sa forme dépend du contexte, de l'histoire, du langage et de la relation. Écouter la plainte n'équivaut pas à supposer que sa cause est exclusivement organique ou exclusivement psychique.

> **À RETENIR**
> Ne jamais disqualifier une plainte faute de signe objectif ni annoncer à la place du patient ce qu'il ressent. Un ressenti ne peut pas être mesuré intégralement de l'extérieur.

Représentations de la maladie et théories profanes

La personne se construit des explications sur **l'origine, le sens, la durée, les conséquences, le contrôle possible et les traitements** de sa maladie. Ces représentations influencent les émotions, la recherche d'aide, l'adhésion ou le refus d'un soin et la manière de vivre avec la pathologie.

Question que se pose le patient	Ce qu'elle explore
« Pourquoi moi ? pourquoi maintenant ? »	Causes, événements de vie, responsabilité éventuelle.
« Qu'est-ce qui va m'arriver ? »	Évolution, conséquences, gravité perçue.
« Qu'est-ce que je peux faire ? »	Contrôle, ressources, choix et traitements.
« Qu'est-ce que je deviens ? »	Identité, rôles sociaux, image du corps, projets.

Les explications dites **profanes** peuvent être exogènes (origine attribuée à l'extérieur de soi) ou intégrer des causes et significations internes. Elles doivent être explorées sans être confondues avec l'étiologie médicale.

EXEMPLE D'ANALYSE

Une personne refuse un traitement parce qu'elle l'associe à un événement traumatisant vécu par un proche. On repère d'abord sa **représentation de la maladie et du soin**, puis on examine son besoin de contrôle ; on n'étiquette pas immédiatement ce refus comme « mauvaise volonté ».

03 · Modèle intégratif et déterminants de la santé

Prédicteurs, modérateurs et issues

Le modèle intégratif présenté en cours articule trois niveaux. Il évite une lecture monocausale de la maladie : aucun facteur biologique, psychologique ou social ne suffit à lui seul à expliquer toutes les trajectoires.

Étape	Rôle	Exemples
Prédicteurs	Facteurs personnels et socio-environnementaux pouvant influer sur risque/pronostic.	Antécédents, conditions de vie, comportements, personnalité.
Modérateurs / processus transactionnels	Manière dont la personne évalue la situation et mobilise ses ressources.	Stress perçu, contrôle perçu, soutien perçu, coping.
Issues / critères d'ajustement	Conséquences sur les dimensions somatiques et psychosociales.	Évolution de l'état de santé, ajustement émotionnel ou comportemental.

Les facteurs de risque, de protection et les événements stressants

Les facteurs personnels comprennent certaines caractéristiques psychologiques, les ressources et les vulnérabilités de la personne. Les facteurs environnementaux concernent le milieu physique, économique, social, culturel et familial. Un **déclencheur** ou **stresseur** survient dans un contexte donné ; le facteur de risque accroît une probabilité, sans constituer un destin individuel.

Les ressources protectrices peuvent amortir un risque : réseau social fiable, capacités d'adaptation, accès à des aides et présence de figures soutenantes. Les facteurs salutogènes désignent des éléments qui favorisent la préservation de la santé et les capacités d'ajustement.

POUR COMPRENDRE

Une même contrainte peut être vécue différemment selon les antécédents, la perception de menace et les ressources mobilisables. Ne pas transformer un facteur statistique en diagnostic individuel.

04 · Soutien social : reçu, perçu et mobilisé

Le soutien social est un concept central. Dans son sens général, il inclut les aides **données et reçues** au sein de l'entourage familial, amical, de voisinage ou institutionnel. Le réseau social n'est pas identique au sentiment d'être réellement soutenu.

Notion	Sens / repère clinique
Réseau social	Ensemble des personnes avec lesquelles l'individu est en relation.
Soutien social reçu	Aides et relations effectivement disponibles ou apportées.
Soutien social perçu	Appréciation subjective de la disponibilité, de la qualité et de l'adéquation du soutien.
Soutien social mobilisé	Démarches et demandes d'aide réalisées pour faire face à une situation.

Les dimensions pratiques et relationnelles

Le cours évoque notamment des soutiens matériels/instrumentaux, émotionnels/affectifs, informatifs, d'estime et d'intégration/appartenance. Les formes concrètes vont de l'aide au logement aux informations pour prendre une décision, en passant par l'écoute et la reconnaissance.

Le soutien perçu peut protéger face aux difficultés : le sentiment de pouvoir compter sur quelqu'un est parfois plus décisif que la seule taille du réseau social. L'isolement peut au contraire constituer un facteur de vulnérabilité.

APPLICATION AU SOIN

Explorer séparément « Qui est présent ? », « Qui peut vraiment vous aider ? » et « Vous sentez-vous soutenu ? ». La quantité de contacts ne renseigne pas à elle seule sur leur qualité.

05 · Vulnérabilité, personnalité et résilience

La vulnérabilité : deux axes

La vulnérabilité correspond à une moindre résistance à certaines agressions ou contraintes, avec des fragilités potentielles, visibles ou latentes. Elle peut relever de facteurs personnels (histoire, caractéristiques biologiques ou psychologiques, développement, ressources) et de facteurs liés à l'environnement (milieu relationnel, sécurité, contexte socio-économique, expériences de vie).

Axe	Éléments cités dans le cours
Personnelle	Caractéristiques individuelles, prédispositions, développement, capacités de régulation.
Environnementale	Carences du milieu, interactions relationnelles inadéquates, contexte social/familial.

La résilience : une pluralité de définitions

Le concept provient notamment de la physique des matériaux puis est repris en psychologie. Il désigne un **processus d'adaptation, de récupération et de réorganisation** après une épreuve ; il ne signifie pas l'absence de douleur ni une invulnérabilité de la personne.

DÉFINITIONS COMPLÈTES ESSENTIELLES

Le cours présente plusieurs formulations complémentaires : celle de **Rutter** sur la capacité à mener une vie normale après des événements très adverses et à développer des stratégies d'ajustement protectrices ; celle de **Boris Cyrulnik** sur le développement malgré un environnement délabrant ; et une définition psychologique générale comme processus permettant de continuer à se construire après une épreuve traumatique. Leurs formulations entières sont reproduites dans « Définitions et mots-clés ».

Les observations longitudinales d'Emmy Werner servent de repère historique pour montrer que certains enfants exposés à des facteurs de risque développent, à l'âge adulte, des capacités d'adaptation satisfaisantes. Le cours souligne l'interaction entre ressources internes et facteurs protecteurs environnementaux.

Personnalité et vulnérabilité

La personnalité est présentée comme un ensemble relativement stable de manières de percevoir, ressentir, penser et agir. Le cours examine certains traits potentiellement associés à la vulnérabilité et au stress, sans permettre de conclure qu'un trait isolé cause une maladie.

L'hostilité est étudiée à travers plusieurs composantes : **cynisme**, **attributions hostiles**, **affects hostiles**, **réponses agressives** et **évitement social**. Il faut distinguer attitudes, émotions et comportements. Des dimensions telles que pessimisme, anxiété ou méfiance peuvent modifier l'évaluation de situations, sans constituer des jugements moraux sur le patient.

À RETENIR

La résilience n'est ni une qualité « héroïque » garantie, ni le contraire automatique de toute vulnérabilité. Elle dépend de l'histoire de la personne, des conditions de l'épreuve et des ressources qui deviennent accessibles.

06 · Stress, évaluation cognitive et contrôle perçu

Le modèle transactionnel du stress

Selon l'approche transactionnelle présentée, le stress traduit une **relation entre la personne et son environnement** évaluée comme menaçante, éprouvante ou dépassant ses ressources. Deux évaluations cognitives sont mises en avant : l'évaluation primaire de la situation (menace, perte, défi) et l'évaluation secondaire des ressources et possibilités d'action.

Phase	Question de la personne	Conséquence sur la réaction
Évaluation primaire	« Que signifie cette situation pour moi ? »	Perception d'une menace, d'une perte ou d'un défi.
Évaluation secondaire	« Ai-je les moyens d'y faire face ? »	Appréciation de ses ressources propres et sociales.
Ajustement	« Quelles actions puis-je entreprendre ? »	Mise en œuvre de coping, recherche de soutien, réévaluation.

La double évaluation explique pourquoi le même diagnostic ou le même événement ne produit pas la même intensité de stress chez toutes les personnes. Le **stress perçu** dépend de cette interprétation subjective.

Le contrôle perçu

Le contrôle perçu décrit la croyance qu'une personne peut agir sur la situation, ses conséquences ou sa propre réaction. Le cours évoque des dimensions de contrôle interne, lié aux autres (« personnages puissants ») et au hasard/chance. Un sentiment de contrôle peut atténuer l'angoisse, mais tout n'est pas contrôlable par la personne malade.

SITUATION INFIRMIÈRE

La personne demande systématiquement des informations sur ses soins : cela peut traduire une tentative de **reprendre du contrôle**, et non seulement de la méfiance. Expliquer les étapes, accueillir les questions et distinguer choix possibles et contraintes réelles.

07 · Stratégies d'ajustement : coping

Le coping désigne les efforts cognitifs et comportementaux déployés face à une situation évaluée comme exigeante ou stressante. Il s'agit de stratégies en lien avec une situation et susceptibles de changer, par opposition aux mécanismes de défense présentés comme largement inconscients.

Type de coping	Objectif	Exemples du cours
Centré sur le problème	Réduire les exigences de la situation ou augmenter les ressources.	Rechercher des informations, élaborer un plan, agir sur la difficulté.
Centré sur l'émotion	Gérer les émotions suscitées par la situation.	Réévaluation positive, mise à distance, expression émotionnelle, diversion.
Centré sur la recherche de soutien	Obtenir écoute, réassurance, informations, aide matérielle.	Solliciter un proche, demander conseil, chercher une aide concrète.

Le cours distingue, pour le coping centré sur le problème, **résolution du problème** et **affrontement de la situation**. Pour le coping centré sur l'émotion, il présente notamment **fuite/évitement**, **minimisation avec distance**, **réévaluation positive**, **auto-accusation** et **recherche de soutien émotionnel**.

ATTENTION AU CONTEXTE

Une stratégie n'est pas bonne ou mauvaise isolément : elle dépend du contexte, du moment et de ses conséquences. La réévaluation positive n'efface pas un risque réel et la recherche de soutien n'est pas synonyme de faiblesse.

08 · Angoisse et mécanismes de défense face à la maladie

Angoisse et fonctions protectrices des défenses

L'angoisse est présentée comme une peur sans objet extérieur défini, exprimant une souffrance psychique face à une menace intérieure. Elle peut servir de signal d'alarme et déclencher des mécanismes de défense. Il s'agit ici du modèle théorique psychanalytique, non d'une structure anatomique.

Les mécanismes de défense sont des réponses **largement inconscientes** par lesquelles le psychisme cherche à se protéger d'une réalité, d'un conflit ou d'une angoisse trop difficile à supporter. Ils peuvent gagner du temps pour intégrer un événement ; ils deviennent problématiques selon leur rigidité, leur intensité, leur fréquence et leurs

conséquences.

PRIORITÉ RELATIONNELLE

Face à une maladie grave, le déni et d'autres défenses peuvent être **protecteurs au début**. Il faut les identifier et généralement les respecter lorsqu'ils ne compromettent pas la santé ou la vie, plutôt que chercher systématiquement à les « casser ».

Les 14 mécanismes explicitement répertoriés

Famille d'observation	Mécanismes à connaître
Rapport à la réalité et aux représentations	Déni ; projection et projection agressive ; refoulement ; isolation ; dénégation.
Réactions d'adaptation et de conduite	Régression ; rationalisation ; déplacement ; maîtrise ; retrait apathique ; activisme et combativité.
Mécanismes pouvant soutenir l'ajustement	Affiliation ; humour ; sublimation.

Ces regroupements servent à réviser et ne constituent pas une classification formelle de l'enseignante. Les définitions intégrales sont regroupées à la fin. **Attention : l'affiliation ici est un mécanisme de défense ; ce n'est pas la notion distincte développée en psychologie sociale.**

Ce qu'observe le soignant

La projection peut se manifester par des reproches dirigés vers les soignants ; la régression, par un besoin accru de dépendance et d'attention ; la maîtrise, par la recherche insistante d'informations. Ces manifestations ne doivent pas être interprétées hors contexte ni étiquetées sans écoute. Les professionnels ont eux aussi des réactions défensives face à la souffrance et aux limites du soin.

EXEMPLE

Après l'annonce d'une maladie, une personne semble impassible et parle des détails matériels. Il peut s'agir d'une manière de se protéger momentanément. Décrire le comportement observé avant d'en proposer l'interprétation.

09 · Annonce du diagnostic et réactions psychiques

L'annonce du diagnostic est abordée comme un acte médical qui peut provoquer un choc psychologique, un bouleversement et une épreuve pour le patient et les proches. Sa signification excède la transmission d'une information biomédicale : elle peut modifier l'identité, susciter une quête de sens et mettre en mouvement un travail de deuil.

Le cours met en parallèle les **stratégies de coping** (plutôt liées à la situation et aux efforts d'ajustement) et les **mécanismes de défense** (en partie structuraux et inconscients). Les réactions ne sont ni uniformes ni nécessairement linéaires.

Les étapes de Kübler-Ross : un repère, pas une obligation

Le support de cours présente une succession descriptive de réactions possibles face à l'annonce :

Étape présentée	Manifestations possibles dans le cours
1 · Sidération / choc	Difficulté momentanée à réaliser, réfléchir ou analyser l'information ; absence de réaction ou de parole.
2 · Déni	Refus de reconnaître la réalité annoncée ; mise en doute de l'information.
3 · Colère / révolte	Sentiment d'injustice, agressivité, culpabilité, révolte.
4 · Marchandage / négociation	Tentatives de négocier modalités et calendrier de prise en charge.
5 · Dépression	Prise de conscience de l'annonce, de la maladie et de ses conséquences.
6 · Acceptation	Prise en compte progressive des contraintes de la maladie, des soins ou des séquelles.

Ces étapes ne constituent pas un calendrier obligatoire ni une méthode pour ranger mécaniquement un patient dans une catégorie. Le cours invite surtout à repérer les réactions réelles et à accueillir leur singularité.

DÉFINITION CENTRALE DE L'ANNONCE

La formulation complète qui précise le **choc psychologique, l'épreuve, le bouleversement et le traumatisme** est reproduite dans le lexique final. Une définition limitée à « dire la maladie au patient » serait incomplète.

Posture relationnelle

- Accueillir une réaction sans l'interpréter d'emblée comme pathologique ; distinguer ce qui est dit, ce qui est observé et ce qui est supposé.
- Reconnaître l'impact sur les proches sans retirer au patient sa place de sujet.
- Respecter un mécanisme protecteur lorsqu'il n'expose pas le patient à un danger et rester attentif aux conséquences sur l'accès aux soins.
- Reformuler, soutenir et transmettre les éléments cliniques pertinents dans le respect des rôles professionnels.

10 · Le corps en psychologie : schéma, image et identité

Le cours distingue le **corps-objet** de la médecine, étudié biologiquement et souvent par organes, et le **corps-sujet** en psychologie : corps vécu, singulier, indissociable de l'histoire, du psychisme, du langage et des relations.

Lorsque la personne est en bonne santé, le corps peut rester au second plan de la conscience. La maladie, la douleur et les transformations corporelles peuvent le rendre central, imposer de nouveaux apprentissages et modifier l'identité vécue.

Notion	Point central
Schéma corporel	Organisation des repères sensorimoteurs et posturaux qui permettent de percevoir et d'utiliser son corps dans l'espace.
Image du corps	Représentation subjective et affective que la personne se construit de son corps et de son apparence.

Notion	Point central
Identité corporelle	Sentiment de continuité et d'appartenance de ce corps à soi, inscrit dans son histoire et son rapport aux autres.

Le cours évoque les travaux sur le stade du miroir, la reconnaissance de soi et le regard d'autrui, puis les bouleversements de l'image corporelle pouvant accompagner des atteintes physiques, une alopécie, une chirurgie ou un handicap.

SITUATION CLINIQUE

À propos d'une modification corporelle, distinguer ce qui change objectivement (capacités, intégrité corporelle) et ce qui change subjectivement (image, honte, identité, confiance, relations). Éviter de minimiser les pertes ressenties par le patient.

Perturbations du schéma corporel et approche psychosomatique

Le cours distingue les atteintes du **schéma corporel**, souvent associées à des lésions ou dysfonctionnements neurologiques, des souffrances liées à l'**image du corps**. Après une amputation, une personne peut continuer à percevoir le membre absent et ressentir une douleur de membre fantôme. Des troubles tels que l'asomatognosie, l'héminégligence ou certaines dyspraxies sont également évoqués comme repères cliniques.

L'**identité corporelle** articule les données du corps réel (schéma corporel) et du corps imaginaire (image du corps). Une intervention mutilante ou une transformation visible peut nécessiter un travail de reconstruction de l'image et du rapport à autrui. Le cours souligne qu'on ne soigne pas seulement un organe : on accompagne une personne qui souffre d'une atteinte corporelle.

L'**approche psychosomatique** cherche à prendre en compte la relation entre psychisme et fonctionnement corporel dans une vision globale de la maladie. Le support souligne une précaution essentielle : une hypothèse d'influence psychique ne permet pas de conclure que le patient se serait rendu malade par sa pensée, ni de remplacer la recherche médicale d'une cause organique.

PRUDENCE ESSENTIELLE

Ne pas transformer l'approche psychosomatique en diagnostic de complaisance ni culpabiliser le patient. Le cours invite à reconnaître les dimensions psychosociales et somatiques sans déclarer comme prouvée une causalité psychique non établie.

11 · Méthode de mobilisation des concepts à l'examen

Le cours annonce une évaluation fondée sur l'analyse d'un **témoignage de patient**. La qualité de la copie ne repose pas sur l'énumération de notions, mais sur leur identification, la définition rédigée en entier et une justification à partir d'indices concrets.

Étape	Réflexe à adopter
1 · Observer	Relever les paroles du patient et les faits explicites sans extrapoler.
2 · Repérer	Sélectionner les concepts effectivement présents : représentations, qualité de vie, contrôle perçu, coping, soutien, défense, image du corps…

Étape	Réflexe à adopter
3 · Définir	Donner une vraie définition en une ou plusieurs phrases complètes.
4 · Justifier	Rattacher précisément la notion à un passage du témoignage.
5 · Nuancer	Ne pas poser de diagnostic psychique à partir d'une phrase ; distinguer hypothèse et fait.

EXEMPLE DE RÉPONSE RÉDIGÉE

« Le patient cherche de l'aide auprès de sa famille et de ses soignants. Cela peut illustrer un soutien social mobilisé : il sollicite des ressources relationnelles pour faire face à une situation difficile. Il faut toutefois vérifier s'il perçoit ce soutien comme réellement disponible et aidant. »

12 · À retenir : connexions importantes

- La santé se comprend dans ses dimensions biologique, psychique et sociale ; la santé perçue reste une donnée subjective essentielle.
- Une maladie se décline en disease, illness et sickness : même diagnostic, vécus et conséquences très différents.
- Le modèle intégratif distingue prédicteurs, modérateurs transactionnels et issues ; les relations ne sont pas mécaniques.
- Le réseau social, le soutien reçu et le soutien perçu sont trois éléments différents.
- Vulnérabilité et résilience peuvent coexister ; la résilience mobilise des ressources internes et environnementales.
- Le stress s'appuie sur une double évaluation cognitive : signification de l'événement puis ressources pour y faire face.
- Les coping centrés sur le problème, les émotions ou la recherche de soutien sont des efforts d'ajustement contextualisés.
- Les mécanismes de défense sont largement inconscients et souvent protecteurs. L'affiliation défensive ne doit pas être confondue avec l'affiliation en psychosociologie.
- L'annonce du diagnostic peut faire choc, modifier l'identité et mobiliser coping et défenses.
- Le corps-objet et le corps-sujet ne résument pas la même réalité ; schéma corporel, image du corps et identité corporelle doivent être différenciés.

13 · Pièges QCM et confusions à éviter

Confusion fréquente	Correction attendue
Soutien social = uniquement aide reçue	Le soutien social général comprend aussi l'aide donnée. Ne pas confondre aide reçue et soutien perçu.
Réseau social étendu = soutien efficace	La qualité et la disponibilité perçue peuvent différer du nombre de relations.
Coping = mécanisme de défense	Le coping désigne des stratégies d'ajustement cognitives et comportementales ; les défenses sont surtout inconscientes.
Toute réaction de déni est néfaste	Le déni peut être momentanément protecteur ; l'enjeu est son intensité, sa rigidité et le risque réel.
Affiliation = même définition partout	En psychologie de la santé : mécanisme de défense. En psychologie sociale : lien / appartenance, étudié séparément.
Résilience = absence de traumatisme	Il y a eu épreuve ; le processus permet de poursuivre une construction malgré l'adversité.
Annonce = simple transmission de faits	Inclure choc psychologique, épreuve et effets sur l'identité et les proches.
Schéma corporel = image du corps	Schéma : repères sensorimoteurs ; image : représentation subjective et affective.
Diagnostic biologique = vécu personnel	Distinguer disease, illness et sickness.
Définition abrégée = réponse complète	L'enseignante exige des formulations grammaticales complètes ; les mots-clés seuls ne suffisent pas.

14 · Synthèse générale — L'essentiel du cours

La psychologie de la santé éclaire la personne au-delà du diagnostic : elle étudie le vécu singulier, les représentations de la maladie, les conditions de vie, le soutien social et les ressources permettant de faire face à une épreuve. La santé est globale, dynamique et subjective ; la maladie se comprend à la fois comme réalité biologique, expérience personnelle et événement social.

Les trajectoires dépendent de facteurs personnels et environnementaux, modulés par l'évaluation cognitive, le contrôle perçu, le soutien perçu et les stratégies de coping. La vulnérabilité ne condamne pas au trouble et la résilience est une construction au croisement de l'individu et de son environnement. Face à l'angoisse ou au choc d'un diagnostic, les mécanismes de défense peuvent protéger momentanément ; le soignant les observe et les respecte lorsqu'ils ne mettent pas en danger la personne.

Pour l'évaluation, le réflexe est constant : **repérer dans le témoignage → nommer précisément le concept → en donner la définition intégrale → montrer quels faits le justifient → nuancer l'interprétation**.

15 · Définitions et mots-clés

Les 59 formulations complètes sont conservées pour une restitution orale ou écrite. Les mots-clés seuls ne remplacent pas une définition précise.

01 · Psychologie de la santé

La psychologie de la santé applique les connaissances psychologiques à l'étude de la santé et de la maladie et cherche à comprendre comment les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et comportementaux interviennent dans la prévention, le maintien de la santé, le vécu et l'évolution des problèmes de santé.

02 · Santé — définition OMS citée

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

03 · Santé perçue

La santé perçue est l'appréciation globale qu'une personne porte elle-même sur son propre état de santé, en intégrant ses sensations, son fonctionnement, ses repères et sa situation.

04 · Qualité de vie

La qualité de vie est la perception qu'un individu a de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.

05 · Approche biopsychosociale

L'approche biopsychosociale considère que la santé et la maladie résultent d'interactions entre des dimensions biologiques, psychologiques et sociales, et qu'aucune de ces dimensions ne suffit seule à résumer la situation de la personne.

06 · Disease

Le terme disease désigne la dimension biomédicale de la maladie, c'est-à-dire l'atteinte, les mécanismes et les signes objectivables étudiés par la médecine.

07 · Illness

Le terme illness désigne l'expérience subjective de la maladie, c'est-à-dire la manière dont une personne ressent, interprète et vit ce qui lui arrive.

08 · Sickness

Le terme sickness désigne la dimension sociale de la maladie, c'est-à-dire la manière dont un trouble est reconnu, interprété et traité dans l'environnement culturel, familial et social.

15 · Définitions et mots-clés — suite

09 · Douleur

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion ; le cours souligne sa dimension personnelle et le fait qu'une lésion objectivable n'est pas indispensable à son existence.

10 · Plainte

La plainte est l'expression adressée à autrui d'un trouble, d'une gêne, d'une douleur ou d'une souffrance, telle que la personne la perçoit et peut la mettre en mots ou en comportements.

11 · Représentations de la maladie

Les représentations de la maladie sont les croyances et explications personnelles, souvent implicites, qu'un individu construit concernant la cause, l'identité, la durée, les conséquences et les possibilités de contrôle ou de traitement de sa maladie.

12 · Théorie profane

Une théorie profane est une explication personnelle de la maladie élaborée par la personne malade ou son entourage, à partir de leurs expériences, de leurs valeurs et de leurs croyances, indépendamment de la validité médicale de cette explication.

13 · Facteur de risque

Un facteur de risque est une caractéristique ou une situation associée à une probabilité plus élevée de rencontrer un problème de santé ; sa présence ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l'apparition d'une maladie.

14 · Facteur de protection

Un facteur de protection est une caractéristique individuelle ou environnementale qui contribue à réduire un risque ou à favoriser les ressources d'adaptation face à une situation défavorable.

15 · Facteur salutogène

Un facteur salutogène est un élément personnel, relationnel ou environnemental qui favorise le maintien de la santé, le bien-être ou les capacités d'ajustement d'une personne.

16 · Soutien social — sens général

Le soutien social renvoie à l'ensemble des aides que des individus dispensent et reçoivent de leur entourage familial, amical, de voisinage ou institutionnel. Il comprend des formes diverses d'aide matérielle, informationnelle, morale ou affective.

17 · Réseau social

Le réseau social est l'ensemble des personnes avec lesquelles un individu est en relation.

15 · Définitions et mots-clés — suite

18 · Soutien social reçu

Le soutien social reçu désigne les caractéristiques observables et les aides effectivement reçues d'autrui, que l'on peut décrire notamment par les relations et ressources présentes dans l'entourage de la personne.

19 · Soutien social perçu

Le soutien social perçu correspond à l'appréciation subjective que la personne porte sur la disponibilité, la pertinence et la qualité de l'aide qu'elle pense pouvoir recevoir de son entourage.

20 · Vulnérabilité

La vulnérabilité se définit par un état de moindre résistance aux nuisances et agressions ; ce concept évoque des faiblesses patentes ou latentes, immédiates ou différées, et peut être compris comme une incapacité ou une difficulté à résister aux contraintes de l'environnement.

21 · Résilience — approche psychologique générale

En psychologie, la résilience désigne globalement un processus qui permet de sortir vainqueur d'une épreuve traumatique et de continuer à se construire malgré l'adversité ; elle suppose récupération après un traumatisme, réorganisation psychique et transformation à travers les épreuves.

22 · Résilience — Rutter (1985)

Capacité pour des individus ayant subi des événements de vie très aversifs, ou même dramatiques, d'arriver à mener une vie normale. Les sujets résilients sont capables de développer, dans des circonstances parfois très difficiles, des stratégies d'ajustement adéquates qui les protègent.

23 · Résilience — Boris Cyrulnik

La résilience définit la capacité à se développer quand même, dans des environnements qui auraient dû être délabrants.

24 · Personnalité

La personnalité désigne l'organisation relativement durable des manières de percevoir, de ressentir, de penser et de se comporter qui contribuent à la singularité d'un individu.

25 · Hostilité

L'hostilité regroupe des dimensions cognitives, émotionnelles et comportementales telles que le cynisme, les attributions hostiles, la colère, la méfiance et les réactions agressives.

26 · Stress transactionnel

Le stress signifie ici une relation entre la personne et son environnement, qui est évaluée par la personne comme tarissant ou excédant ses ressources et menaçant son bien-être.

15 · Définitions et mots-clés — suite

27 · Évaluation primaire

L'évaluation primaire est l'opération cognitive par laquelle une personne détermine ce que représente une situation pour elle, notamment une menace, une perte ou un défi.

28 · Évaluation secondaire

L'évaluation secondaire est l'opération cognitive par laquelle une personne apprécie les ressources et les possibilités d'action qu'elle estime disposer pour faire face à une situation.

29 · Contrôle perçu

Le contrôle perçu correspond à la représentation que se fait une personne de sa possibilité d'agir sur un événement, ses causes, son déroulement, ses conséquences ou ses propres réactions.

30 · Coping / stratégies d'ajustement

Le coping désigne les efforts cognitifs et comportementaux qu'une personne met en œuvre pour faire face à une situation évaluée comme stressante ou dépassant ses ressources habituelles.

31 · Coping centré sur le problème

Le coping centré sur le problème vise à réduire les exigences de la situation et/ou à augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face, notamment par la recherche d'informations, la résolution de problèmes, la planification et l'action directe.

32 · Coping centré sur l'émotion

Le coping centré sur l'émotion vise à gérer les réponses émotionnelles induites par la situation, en détournant son attention, en réinterprétant positivement l'événement, en minimisant les conséquences ou en évitant temporairement la situation.

33 · Coping centré sur le soutien social

Le coping centré sur la recherche de soutien social rassemble les efforts effectués pour obtenir la sympathie, l'écoute, les informations ou l'aide matérielle et pratique d'autrui.

34 · Angoisse

L'angoisse désigne un éprouvé d'inquiétude et de menace psychique pouvant déborder les capacités habituelles du sujet à penser ou à faire face à ce qu'il vit. Elle peut susciter des réponses de protection et des mécanismes de défense.

35 · Mécanismes de défense

Les mécanismes de défense sont produits de manière inconsciente ; ils regroupent ce que le psychisme met en place lorsque la réalité est insupportable, afin de se protéger contre l'angoisse et de maintenir un certain équilibre. Face à un événement traumatique, ils peuvent laisser à la personne du temps pour intégrer ce qu'elle vit.

15 · Définitions et mots-clés — suite

36 · Déni

Le déni est l'action de refuser la réalité d'une perception vécue comme dangereuse ou douloureuse pour le moi.

37 · Projection

La projection est une opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées, des affects ou des désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui et qu'il attribue à d'autres personnes ou choses de son environnement.

38 · Projection agressive

La projection agressive peut se manifester par des réactions agressives et revendicatrices du patient, sous forme de reproches, de plaintes ou d'insatisfaction orientés vers l'extérieur face à la maladie.

39 · Régression

La régression constitue un retour à des modes d'expression antérieurs de la pensée, des conduites ou des relations objectales, face à un danger interne ou externe susceptible de provoquer un excès d'angoisse ou de frustration.

40 · Rationalisation

La rationalisation est une justification logique, mais artificielle, qui camoufle, à l'insu de celui qui l'utilise, les vrais motifs irrationnels et inconscients de certains de ses jugements, conduites ou sentiments, car ces motifs ne pourraient être reconnus sans anxiété.

41 · Refoulement

Le refoulement est le rejet dans l'inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent actives tout en étant inaccessibles à la prise de conscience. Le retour du refoulé peut intervenir lorsque le refoulement échoue ou devient insuffisant.

42 · Déplacement

Le déplacement est la généralisation ou le déplacement d'un problème vers un autre objet habituellement moins menaçant : l'affect et le sentiment restent reconnus et exprimés, mais ils sont redirigés vers une cible moins conflictuelle, bien que de même nature.

43 · Isolation

L'isolation désigne une élimination de l'affect lié à une représentation conflictuelle (souvenirs, idées ou pensées), alors que la représentation en question reste consciente.

44 · Dénégation

La dénégation est le refus de reconnaître comme siens, immédiatement après les avoir formulés, une pensée, un désir ou un sentiment qui sont source de conflit.

15 · Définitions et mots-clés — suite

45 · Maîtrise

La maîtrise vise à diminuer l'angoisse liée à l'incertitude de la maladie à travers la restauration d'un sentiment de contrôle sur la situation ; la personne veut agir sur sa propre histoire et sur la maladie en croyant pouvoir en contrôler le processus.

46 · Retrait apathique

Le retrait apathique est un détachement protecteur, fait d'indifférence affective, de restriction des relations sociales et des activités extérieures, et de soumission passive aux événements, qui permet à une personne de supporter une situation très difficile.

47 · Activisme

L'activisme consiste à gérer les conflits psychiques ou les situations traumatiques externes par le recours à l'action, à la place de la réflexion ou du vécu des affects.

48 · Combativité

La combativité est une forme d'activisme qui neutralise l'angoisse et le désarroi du malade en suscitant une énergie importante lui permettant de dépasser la maladie et de se dépasser lui-même.

49 · Affiliation — mécanisme de défense

L'affiliation est la recherche de l'aide et du soutien d'autrui quand on vit une situation qui engendre de l'angoisse. Dans ce chapitre, elle désigne un mécanisme de défense, et non le concept distinct d'affiliation en psychologie sociale.

50 · Humour — mécanisme de défense

L'humour est un processus qui consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à en dégager les aspects plaisants, ironiques ou insolites. C'est uniquement l'humour appliqué à soi-même qui peut être considéré comme un mécanisme de défense.

51 · Sublimation

La sublimation peut renvoyer à la désexualisation d'une pulsion qui se transforme en tendresse ou en amitié sans changer d'objet ; elle peut aussi désigner la dérivation de l'énergie d'une pulsion sexuelle ou agressive vers des activités socialement valorisées, notamment artistiques, intellectuelles ou morales.

52 · Annonce du diagnostic

L'annonce du diagnostic est l'acte médical par lequel un médecin fait part à un patient du diagnostic d'une pathologie aiguë ou chronique, ou d'un handicap. L'annonce du diagnostic est toujours un choc psychologique, une épreuve, un bouleversement et un traumatisme pour le patient et ses proches, au sens où cette annonce fait effraction dans le psychisme.

15 · Définitions et mots-clés — suite

53 · Approche psychosomatique

L'approche psychosomatique est une approche clinique globale qui cherche à relier les dimensions psychiques et somatiques de la personne, en tenant compte de son histoire, de ses relations et de ses conditions de vie, sans réduire une maladie à une cause uniquement mentale.

54 · Douleur du membre fantôme

La douleur du membre fantôme est une douleur que la personne peut ressentir comme provenant d'un membre amputé, bien que ce membre ne soit plus présent ; elle illustre les perturbations possibles du vécu et des représentations corporelles.

55 · Corps-objet

Le corps-objet désigne le corps que la médecine peut observer et étudier scientifiquement, notamment par l'anatomie, la physiologie et l'étude de ses organes.

56 · Corps-sujet

Le corps-sujet est le corps singulier vécu par la personne, indissociable du psychisme, du langage, de son histoire et de sa relation à autrui.

57 · Schéma corporel

Le schéma corporel est l'organisation des repères sensoriels, moteurs et posturaux qui permet à une personne de se situer, de percevoir et de mobiliser son corps dans l'espace et dans l'action.

58 · Image du corps

L'image du corps est la représentation subjective, psychique et affective qu'une personne construit de son propre corps, de son apparence et de sa valeur corporelle au regard de son histoire et des relations avec autrui.

59 · Identité corporelle

L'identité corporelle désigne le sentiment d'être soi dans et avec son corps et de conserver une continuité de soi malgré les transformations, les expériences et les perceptions corporelles.